

CAPÍTULO 6.6

Objetivos del Control Metabolico

PERFIL EUNACOM 1.04.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Objetivos de Control en Diabetes Mellitus

Objetivo principal: HbA1c

TABLA 6.6.1: PACIENTE VS HBA1C OBJETIVO		
PACIENTE	HBA1C OBJETIVO	
General	< 7%	
Hipoglicemias - Generalidades	Hipoglicemias frecuentes	< 8%
Niño pequeño (no sigue instrucciones)	< 8%	
> 75 años	< 8%	
Esperanza de vida < 10 años o comorbilidad severa	< 8%	

- Se pide cada **3 meses**; puede espaciarse a 6 meses cuando ya está estable - Refleja glicemia promedio de los últimos **2-3 meses** ("examen chismoso")

Objetivos adicionales

TABLA 6.6.2: VARIABLE VS OBJETIVO	
VARIABLE	OBJETIVO
Presión arterial	< 130/80 mmHg (si hay nefropatía o microalbuminuria: < 130/80 obligatorio)
LDL	< 70 mg/dL (todos los DM son alto riesgo CV → iniciar estatina casi siempre)
Triglicéridos	< 150 mg/dL (idealmente < 100)
HDL	Hombres > 40 / Mujeres > 50

EUNACOM CRITERIOS

La DM **no eleva el LDL**, pero el diabético tiene máximo riesgo cardiovascular → el objetivo de LDL es más estricto que en la población general.

Lo que NO cambia la HbA1c sola

- Glicemias aisladas, ya sean pre o postprandiales, son orientadoras para el ajuste de insulina/HGO
- Si la HbA1c está en rango, una glicemia postprandial de 190 puntual **no obliga** a ajuste

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 60 años con DM2 e infarto previo consulta para control. Examen: PA 125/75 mmHg, IMC 28 kg/m², HbA1c 6.8%, LDL 52 mg/dL, RAC urinario 18 mg/g."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Objetivos de Control Metabólico en DM2: HbA1c < 7.0% (individualizar < 6.5% en jóvenes, < 8.0% en adultos mayores frágiles), PA < 130/80 mmHg, LDL < 55 mg/dL en muy alto riesgo CV (con infarto previo), y RAC < 30 mg/g.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- HbA1c menor a 7% es el objetivo mas importante. Con este nivel se evitan complicaciones crónicas.
- Objetivo cambia a menor a 8% en: mucha hipoglicemia, niños pequeños, expectativa de vida menor a 10 años, mayores de 75 años.
- HbA1c se pide cada 3 meses, estable cada 6 meses. Refleja últimos 2-3 meses.
- Presion arterial objetivo: 130/80. Con nefropatia es obligatorio 130/80.
- LDL bajo 70 en diabeticos (maximo riesgo cardiovascular). Iniciar estatinas casi siempre.
- Trigliceridos altos y HDL bajo son las complicaciones lipidicas clasicas de la diabetes.
- Las glicemias individuales sirven para ajustar tratamiento, pero la HbA1c manda en las decisiones.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OBJETIVOS DEL CONTROL METABOLICO)

PREGUNTA 1

Paciente diabético de 78 años con HbA1c de 7.8%. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al control metabólico?

- A)** Intensificar tratamiento para lograr HbA1c menor a 7%
- B)** Mantener tratamiento actual sin cambios
- C)** Suspender hipoglucemiantes por riesgo de hipoglucemia
- D)** Agregar insulina para bajar HbA1c
- E)** Solicitar perfil lipídico y suspender estatinas

PREGUNTA 2

¿Cuál es el objetivo de LDL en un paciente diabético y por qué?

- A)** Menor a 100 porque tiene riesgo cardiovascular moderado
- B)** Menor a 70 porque la diabetes es equivalente coronario con riesgo cardiovascular máximo
- C)** Menor a 130 porque no tiene mayor riesgo
- D)** Menor a 160 si no hay otros factores de riesgo
- E)** No tiene objetivo específico porque la diabetes no afecta el LDL

PREGUNTA 3

Paciente diabético de 55 años con HbA1c 6.5% presenta hipoglucemias frecuentes con síntomas neuroglucopénicos. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Mantener tratamiento, la HbA1c está óptima
- B)** Cambiar objetivo de HbA1c a menor a 8% y reducir tratamiento
- C)** Agregar más insulina para evitar descompensaciones
- D)** Solo agregar colaciones sin cambiar fármacos
- E)** Hospitalizar para estudio

RESUMEN: OBJETIVOS DEL CONTROL METABOLICO

El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es evitar complicaciones agudas (cetoacidosis, síndrome hiperglicémico, hipoglucemia) y crónicas (retinopatía, pie diabético, nefropatía, neuropatía). Esto se traduce en una hemoglobina glicosilada menor a 7%, que es el objetivo más importante. El corte cambia a menor de 8% en ciertas situaciones: mucha hipoglucemia, niños muy pequeños que no siguen instrucciones, expectativa de vida menor a 10 años, mayores de 75 años, y comorbilidad severa. La HbA1c se pide cada 3 meses, y cuando está estable se puede espaciar a cada 6 meses. Las glicemias preprandiales se buscan bajo 130 (algunas guías dicen bajo 100) y las postprandiales bajo 180 (algunas dicen bajo 130). La presión arterial objetivo es menor a 130/80 (obligatorio con nefropatía). El perfil lipídico exige triglicéridos bajo 150, HDL normal (hombres mayor a 40, mujeres mayor a 50), y LDL bajo 70 en diabéticos por su máximo riesgo cardiovascular.